

SCANNER & IRM HAUTS-DE-FRANCE

Centre d'Imagerie Médicale
3 rue Nationale
59000 LILLE
Résultats : imagerie-hdf.fr
Téléphone : 03.20.00.00.00

Nom : DUBOIS
Prénom : Alain
Date de naissance : 18/03/1947
Sexe : M

Lille, le 23/04/2026
Dr Thomas LEROY
Médecin radiologue

SCANNER THORACO-ABDOMINO-PELVIER

Indication :

Douleur abdominale aiguë intense, d'apparition brutale, disproportionnée par rapport à l'examen clinique, chez un patient avec antécédents cardiovasculaires (fibrillation auriculaire).
Suspicion d'ischémie mésentérique

Technique :

Acquisition tomodensitométrique thoraco-abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisitions aux temps artériel et portal.
Reconstructions multiplanaires.
Analyse en fenêtres vasculaire, digestive et parenchymateuse.

Résultats :

Vascularisation mésentérique :

Défaut de rehaussement au niveau de l'artère mésentérique supérieure (AMS) proximale, avec image de lacune endoluminale compatible avec une thrombose/embolie.

Diminution du rehaussement des branches distales mésentériques.

Intestin grêle :

Plusieurs anses grêles présentent un épaississement pariétal avec un défaut de rehaussement, traduisant une souffrance ischémique. Présence d'un discret pneumatosis intestinalis (gaz intramural). Dilatation modérée des anses en amont.

Cavité péritonéale :

Présence d'un épanchement péritonéal de faible à modérée abondance.

Présence de quelques bulles d'air portales intra-hépatiques (aéroportie).

Foie et voies biliaires :

Foie de morphologie conservée.

Présence d'aéroportie visible sous forme de fines bulles gazeuses périphériques.

Voies biliaires non dilatées.

Pancréas :

Pancréas sans anomalie.

Rate :

Rate de taille normale.

Reins :

Rehaussement cortical conservé.

Pas d'anomalie significative.

Thorax :

Pas d'embolie pulmonaire visible.

Pas d'épanchement pleural significatif.

Structures osseuses :

Pas d'anomalie suspecte.

Conclusion :

Aspect en faveur d'une **ischémie mésentérique aiguë d'origine artérielle (AMS)**, avec signes de gravité :

- défaut de rehaussement intestinal,
- pneumatosis intestinalis,
- aéroportie.

Tableau compatible avec une **souffrance intestinale avancée**, possiblement compliquée de nécrose.

Recommandations :

Urgence médico-chirurgicale absolue.

Avis chirurgical immédiat.

Discussion d'une revascularisation en urgence et/ou résection intestinale.